Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 07

Neoplasias Digestivas e Ostomias

Câncer de esôfago, gástrico e colorretal; cuidados com ostomias

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Resumo elaborado pelo monitor para orientar o estudo. Não é referência bibliográfica *e pode conter erros: para estudo, prova e recursos, valem as aulas, as diretrizes e as fontes indicadas pela disciplina.*

Sumário

Suspeitar, confirmar com biópsia, estadiar e só então tratar

I Câncer de esôfago 3
Carcinoma escamoso × adenocarcinoma, disfagia, estadiamento e tratamento por estádio

II Câncer gástrico 5
H. pylori, Lauren e Borrmann, sinais de doença avançada, margens e linfadenectomia D2

III Câncer colorretal 7
Rastreamento no SUS, cólon direito × esquerdo × reto, cólon × reto no tratamento, urgência

IV Ostomias: a prática da aula 10
Tipos, demarcação, estoma normal, complicações e troca da bolsa passo a passo

V Armadilhas e sequência mental 12
Erros comuns e o raciocínio em 30 segundos

— Pontos clássicos de prova 13
Epônimos e classificações que ainda caem

— Referências e créditos das imagens 14

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

Câncer de esôfago

Disfagia progressiva com emagrecimento é câncer de esôfago até prova em contrário. Quando ela aparece, a luz já está muito reduzida e a doença costuma estar avançada.

São dois tumores diferentes que dividem o mesmo órgão. O **carcinoma escamoso** (espinocelular) vem do epitélio do próprio esôfago. O **adenocarcinoma** nasce da metaplasia intestinal do esôfago de Barrett, consequência do refluxo crônico. O tabagismo é fator de risco comum aos dois.

Tabela 1. *Os dois tipos histológicos*

	Carcinoma escamoso	Adenocarcinoma
Fatores de risco	Tabaco e álcool (efeito sinérgico), bebidas muito quentes, acalasia (inclusive chagásica), estenose por cáustico, tilose	Refluxo crônico, esôfago de Barrett, obesidade, tabaco
Localização	Terços superior e médio	Terço distal e junção esofagogástrica
Perfil típico	Homem, etilista e tabagista, baixa renda	Homem branco, obeso, com refluxo de longa data
Tendência	Ainda o mais comum no Brasil	Crescendo no Ocidente, junto com a obesidade

São tendências, não regras: um escamoso pode ser distal e um adenocarcinoma pode surgir sem Barrett conhecido.

Clínica

A **disfagia** começa para sólidos e progride para pastosos e líquidos em semanas a meses. Vem com perda de peso rápida, às vezes odinofagia e anemia. Rouquidão sugere invasão do nervo laríngeo recorrente. Tosse ao engolir e pneumonias de repetição sugerem **fístula traqueoesofágica**: é doença irressecável.

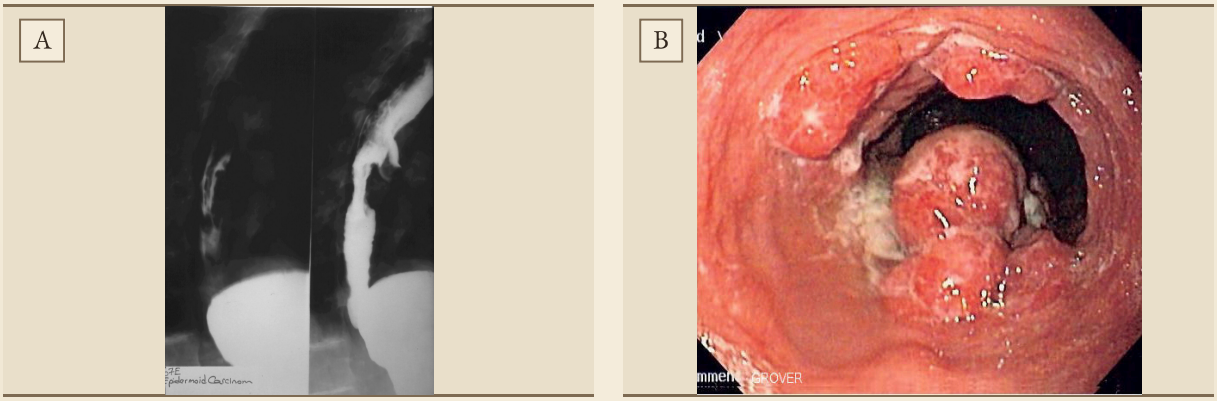


Figura 1. *(A) Esofagograma contrastado: estreitamento irregular, com bordas abruptas ("degrau") e mucosa destruída, típico de tumor. (B) Endoscopia: adenocarcinoma vegetante e friável na junção esofagogástrica.*

(A) Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0 · (B) Samir, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Diagnóstico e estadiamento

O exame que confirma é a **endoscopia digestiva alta com biópsia**. O esofagograma pode sugerir o tumor, mas não substitui a histologia. Com o diagnóstico, estadie: a **TC de tórax e abdome** procura metástases; a **ecoendoscopia** é o melhor exame para a profundidade (T) e os linfonodos regionais (N); o **PET-CT** acha metástases ocultas que a TC não mostrou. Nos tumores do esôfago superior e médio, a broncoscopia avalia invasão da via aérea.

Tabela 2. *O tratamento segue o estádio*

Estádio	Conduta
Superficial selecionado (T1a), sem invasão linfovascular; a peça confirma se foi curativo	Ressecção endoscópica (mucosectomia ou dissecção submucosa)
T1b a T2, sem linfonodo (N0)	Esofagectomia; no T2, tratamento multimodal conforme histologia e equipe
Localmente avançado: T3–T4a ou linfonodo positivo, M0	Tratamento neoadjuvante seguido de esofagectomia. Escamoso: quimiorradioterapia (esquema CROSS). Adenocarcinoma: de preferência quimioterapia perioperatória (FLOT); quimiorradioterapia se não tolerar
Escamoso do esôfago cervical	Quimiorradioterapia definitiva, porque a cirurgia exigiria retirar a laringe
T4b (aorta, traqueia, vértebra), sem metástase	Quimiorradioterapia definitiva, ainda com intenção curativa
Metastático (M1)	Tratamento sistêmico e alívio da disfagia: prótese esofágica, radioterapia, via alimentar (gastrostomia ou jejunostomia)

Fontes: van Hagen et al., NEJM 2012 (CROSS); Hoeppner et al., NEJM 2025 (ESOPEC).

Atenção · mudou em 2025

No **adenocarcinoma** localmente avançado, o estudo ESOPEC comparou a quimioterapia perioperatória FLOT com a quimiorradioterapia do CROSS, e o FLOT teve maior sobrevida. Por isso, muitos serviços passaram a preferir o FLOT no adenocarcinoma. No **escamoso**, a quimiorradioterapia continua sendo a base. Mesmo com resposta completa à neoadjuvância, o padrão ainda é operar; a vigilância sem cirurgia é estudada em centros selecionados (estudo SANO). Se sobrar tumor na peça após quimiorradioterapia, o nivolumabe adjuvante é opção (CheckMate 577).

Vias de esofagectomia: trans-hiatal (abdome e pescoço, sem toracotomia), Ivor Lewis (abdome e tórax, anastomose torácica: a fístula causa mediastinite) e McKeown (abdome, tórax e pescoço, anastomose cervical). O estômago em tubo substitui o esôfago.

Cai na prova

Disfagia progressiva + emagrecimento: **endoscopia com biópsia**. Escamoso: **tabaco e álcool, terço médio**. Adenocarcinoma: **Barrett e obesidade, terço distal**. Fístula para a via aérea e invasão da aorta tornam o tumor irressecável.

Capítulo II

Câncer gástrico

Quase todo câncer gástrico é adenocarcinoma, e o principal fator de risco é o Helicobacter pylori. Dispepsia com sinal de alarme pede endoscopia.

Fatores de risco: *H. pylori* (gastrite crônica → atrofia → metaplasia intestinal → displasia → câncer), dieta rica em sal e alimentos defumados ou conservados, tabagismo, gastrite atrófica autoimune (anemia perniciosa), gastrectomia prévia, pólipo adenomatoso e história familiar. A mutação do gene **CDH1** causa o câncer gástrico difuso hereditário.

Sinais de alarme da dispepsia: idade de início mais alta, perda de peso, disfagia, vômitos persistentes, anemia ou sangramento digestivo, massa palpável e história familiar de câncer gástrico.

Tabela 3. *Classificação de Lauren*

	Intestinal	Difuso
Origem	Passa pela metaplasia intestinal; ligado ao *H. pylori* e ao ambiente	Sem metaplasia prévia; componente genético (CDH1)
Microscopia	Forma glândulas, bem diferenciado	Células pouco coesas, muitas vezes em anel de sinete
Paciente	Mais velho, homem	Mais jovem, ambos os sexos
Disseminação	Hematogênica (fígado)	Pela parede e pelo peritônio; pode virar **linite plástica**
Prognóstico	Melhor	Pior

Sinais que sugerem doença disseminada (precisam de confirmação, mas, confirmados, afastam a cirurgia curativa): linfonodo supraclavicular esquerdo (**Virchow**), linfonodo axilar esquerdo (**Irish**), nódulo umbilical (**Irmã Maria José**), implante no fundo de saco palpável ao toque retal (**prateleira de Blumer**), metástase ovariana (**Krukenberg**) e ascite com carcinomatose.

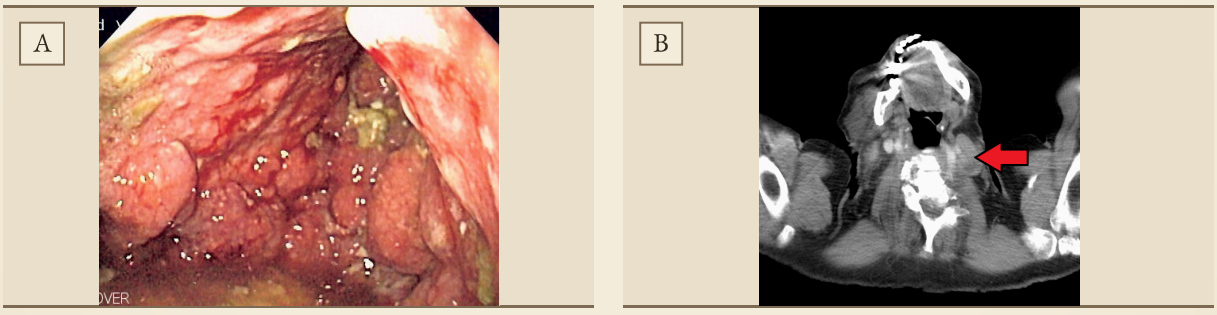


Figura 2. *(A) Endoscopia: estômago tomado por tumor infiltrativo e ulcerado, com parede rígida (linite plástica, Borrmann IV). (B) TC do pescoço: linfonodo supraclavicular esquerdo aumentado, o linfonodo de Virchow (seta).*

(A) Samir, CC BY-SA 3.0 · (B) James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Diagnóstico e estadiamento

Endoscopia com múltiplas biópsias, descrevendo a distância até a cárdia e o piloro. Estadie com **TC de tórax, abdome e pelve**. Nos tumores avançados candidatos a tratamento, a **laparoscopia diagnóstica com lavado peritoneal** procura implantes que a TC não enxerga; **citologia do lavado positiva já é M1**, mesmo sem implante visível. A ecoendoscopia ajuda a decidir entre ressecção endoscópica e cirurgia no tumor inicial. Câncer gástrico **precoce** é o restrito à mucosa ou à submucosa, com ou sem linfonodo.

Tabela 4. *Do tumor inicial ao avançado*

Situação	Conduta
Adenocarcinoma diferenciado, restrito à mucosa (T1a), ≤ 2 cm, sem úlcera	Ressecção endoscópica (mucosectomia ou dissecção submucosa)
Tumor ressecável, cT2 ou mais, ou linfonodo positivo	Gastrectomia com linfadenectomia D2. No Ocidente e no Brasil, em paciente apto, soma-se a quimioterapia perioperatória (FLOT)
Tumor distal (antro)	Gastrectomia subtotal, se a margem proximal for suficiente
Tumor proximal, ou margem insuficiente	Em geral, gastrectomia total com reconstrução em Y de Roux; gastrectomia proximal em casos iniciais selecionados
Metastático ou irressecável	Tratamento sistêmico. Obstrução: gastrojejunostomia ou prótese. Sangramento: endoscopia ou radioterapia

Fontes: endoscopia, margens e D2: diretriz japonesa, 7ª ed. (JGCA 2025). Quimioterapia perioperatória: Al-Batran et al., Lancet 2019 (FLOT4); a diretriz japonesa não a adota como padrão.

Margem proximal macroscópica

T1: 2 cm. **T2 ou mais, crescimento expansivo** (Borrmann I e II): 3 cm. **Infiltrativo** (Borrmann III e IV): 5 cm. Na dúvida, congelação da margem. O objetivo é a ressecção R0, sem tumor na margem.

Linfadenectomia

D2 no tumor cT2 ou mais, ou com linfonodo positivo: retira os perigástricos e os do tronco celíaco e seus ramos. D1 ou D1+ no tumor inicial que não cabe na endoscopia. Examine pelo menos **16 linfonodos**. Não retire o baço de rotina.

Atenção · cuidado com a "margem de 6 cm"

Muitos materiais ainda ensinam "margem de 6 cm". A diretriz japonesa usa **3 cm** para o tumor expansivo e **5 cm** para o infiltrativo desde 2010, e manteve esses valores na edição de 2025.

Outros tumores do estômago

Linfoma MALT: associado ao *H. pylori*; o primeiro tratamento é **erradicar a bactéria**, não operar. **GIST:** tumor das células intersticiais de Cajal, marcador **CD117 (KIT)**; ressecção com margem livre, **sem linfadenectomia**; imatinibe no tumor de alto risco ou metastático, guiado pela pesquisa de mutação (algumas, como PDGFRA D842V, não respondem).

Capítulo III

Câncer colorretal

É um dos cânceres mais frequentes no Brasil e em geral nasce de um pólipo (adenoma ou lesão serrilhada). Por isso o rastreamento salva vidas: tirar o pólipo previne o câncer.

Fatores de risco: idade (o principal), história pessoal ou familiar de câncer colorretal ou adenoma, doença inflamatória intestinal, síndromes hereditárias (polipose adenomatosa familiar e síndrome de Lynch), obesidade, sedentarismo, carne processada, álcool e tabaco.

Atenção · mudou em maio de 2026 · rastreamento no SUS

O SUS adotou o **teste imunoquímico fecal (FIT)** como exame de referência para pessoas **assintomáticas de 50 a 75 anos** com risco habitual. Teste positivo: **colonoscopia**. Rastreamento é para quem não tem sintomas. Quem tem sangramento, anemia ou mudança do hábito intestinal vai direto para a investigação. Diretrizes estrangeiras começam aos 45 anos, mas essa não é a regra do SUS. **Alto risco** (parente de 1º grau com câncer colorretal, síndrome hereditária, doença inflamatória intestinal) não entra no FIT: tem avaliação própria, em geral com colonoscopia mais cedo.

Tabela 5. *A clínica muda com o lado*

Local	Apresentação típica	Por quê
Cólon direito	Anemia ferropriva, fraqueza, massa palpável; raramente obstrui	Luz larga e fezes ainda líquidas
Cólon esquerdo	Mudança do hábito intestinal, fezes afiladas, sangue nas fezes, cólica, **obstrução**	Luz estreita e fezes sólidas; tumor anelar ("maçã mordida")
Reto	Sangramento vivo, **tenesmo**, puxo, fezes com muco	Tumor palpável ao toque retal

Anemia ferropriva em homem ou em mulher após a menopausa pede investigação do tubo digestivo.

Diagnóstico e estadiamento

Colonoscopia completa com biópsia: confirma e procura tumor ou pólipo sincrônico no restante do cólon. Estadie com **TC de tórax, abdome e pelve** e dosagem do **CEA**. No reto, a **ressonância da pelve** mostra a invasão local, os linfonodos e a distância do tumor à fáscia do mesorreto (margem circunferencial), e orienta a neoadjuvância. Pesquise também a **instabilidade de microssatélites (MMR/MSI)**: o tumor com deficiência de reparo pode responder à imunoterapia. O CEA não faz diagnóstico: serve para prognóstico e seguimento.

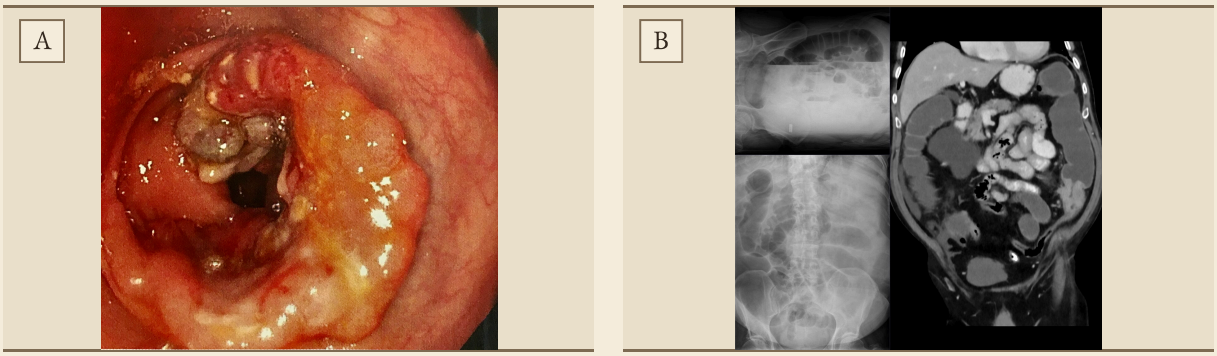


Figura 3. *(A) Colonoscopia: tumor ulcerado e vegetante que estreita a luz do cólon. (B) Obstrução por tumor estenosante do cólon descendente: na radiografia, cólon distendido com níveis; na TC coronal, cólon dilatado até o ponto da estenose.*

(A) Dr. Gannavarapu Narasimhamurthy, CC0 · (B) Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Tabela 6. *Cólon e reto não se tratam igual*

	Cólon	Reto médio e baixo
Primeiro passo	Cirurgia	Depende da RM: T3–T4 ou linfonodo positivo recebe **neoadjuvância** antes
Cirurgia	Colectomia do segmento com ligadura dos vasos na origem e seu mesentério	Ressecção com **excisão total do mesorreto**: ressecção anterior baixa ou amputação abdominoperineal
Margem	Cerca de 5 cm de cada lado	Distal de 1–2 cm (1 cm pode bastar no reto baixo após neoadjuvância)
Linfonodos	Examinar pelo menos **12** para estadiar com segurança	
Depois da cirurgia	Quimioterapia adjuvante no estádio III; no II de alto risco, discutir (conforme MMR/MSI)	Conforme a resposta e o tratamento feito antes

Fontes: ASCRS, diretrizes de câncer de cólon (2022) e de reto (2023).

Amputação abdominoperineal (Miles): retira reto e ânus e deixa **colostomia definitiva**; é indicada quando o tumor invade o esfíncter externo ou os elevadores, ou quando não há margem distal. **Ressecção anterior baixa:** preserva o esfíncter; costuma vir com **ileostomia de proteção** temporária, sobretudo após radioterapia. No reto, quem tem resposta clínica completa à neoadjuvância pode, em centro preparado, seguir em vigilância rigorosa sem operar ("watch and wait").

Cai na prova

Metástase hematogênica vai primeiro ao **fígado**, pela veia porta. O **reto distal** pode mandar metástase direto ao **pulmão**, pelas veias retais inferiores, que drenam na cava. Metástase hepática ressecável **pode ser operada com intenção curativa**.

Câncer colorretal na urgência

Muitos pacientes chegam ao pronto-socorro já obstruídos ou perfurados, e o tumor é descoberto na cirurgia. A conduta depende do lado, da estabilidade e do estado do intestino.

Tabela 7. *Obstrução e perfuração*

Cenário	Conduta habitual
Obstrução do cólon direito ou transverso	Colectomia direita (ou estendida) com anastomose ileocólica se estável e bem perfundido; senão, ileostomia
Obstrução do cólon esquerdo, paciente estável	Ressecção com anastomose, com ou sem estoma de proteção; prótese endoscópica como ponte até a cirurgia eletiva; ou estoma descompressivo
Obstrução esquerda com instabilidade, peritonite ou alça sem condição	Cirurgia de **Hartmann**: ressecção, colostomia terminal e coto retal fechado
Obstrução por tumor de reto médio ou baixo, sem perfuração	**Estoma derivativo** (colostomia em alça), sem ressecar; depois estadiamento e neoadjuvância
Perfuração	Cirurgia de urgência, ressecção do segmento; Hartmann é comum quando há peritonite fecal

Atenção · o ceco que vai romper

Com a **válvula ileocecal competente**, o cólon obstruído vira uma alça fechada: o gás não volta para o delgado. O ceco, o segmento mais largo, é o que mais distende e perfura. Ceco muito dilatado na imagem (classicamente acima de 12 cm), com dor localizada na fossa ilíaca direita, pede descompressão urgente.



Figura 4. *TC coronal: fígado tomado por metástases de câncer de cólon, e tumor no cólon (seta). O fígado é o primeiro destino das metástases porque recebe o sangue do intestino pela veia porta.*

James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Cai na prova · Hartmann não é resposta automática

No cólon esquerdo obstruído, Hartmann é a saída para o paciente **instável ou com peritonite**. No estável, ressecção com anastomose ou prótese como ponte também são válidas. No **reto médio ou baixo** obstruído e sem perfuração, não se resseca na urgência: **deriva** e trata depois.

Capítulo IV

Ostomias: a prática da aula

Estomia é a exteriorização de uma víscera oca na pele. A boa estomia começa antes da cirurgia, com a demarcação, e continua com a pele periestomal íntegra.

Tabela 8. *Os tipos que você precisa reconhecer*

	Colostomia	Ileostomia	Urostomia
Onde fica	Em geral à esquerda (descendente ou sigmoide)	Em geral à direita (íleo terminal)	À direita (conduto ileal de Bricker)
Efluente	Fezes pastosas a formadas	Líquido, contínuo e rico em enzimas	Urina, contínua
Altura	Pouco acima da pele	Protrusa, 2–3 cm, para o líquido cair longe da pele	Protrusa
Risco principal	Hérnia paraestomal, prolapso	Dermatite e **desidratação** pelo alto débito	Infecção urinária, dermatite

Terminal *(uma boca)* × ***em alça*** *(duas bocas, em geral temporária, para proteger uma anastomose).* ***Temporária*** × ***definitiva*** *(após amputação abdominoperineal).*

Demarcação pré-operatória

Feita antes da cirurgia eletiva, de preferência pelo estomaterapeuta. O local fica **sobre o músculo reto abdominal**, numa área plana, **visível para o próprio paciente**, longe de pregas, cicatrizes, umbigo, cintura da roupa e proeminências ósseas. Teste com o paciente **em pé, sentado e deitado**.

Estoma normal

Vermelho vivo ou rosado, úmido e brilhante, como a mucosa da boca. É indolor ao toque e sangra um pouco com facilidade. Fica edemaciado nas primeiras semanas e diminui depois: **meça de novo a cada troca** nesse período. Escuro ou preto: avaliação urgente do cirurgião.

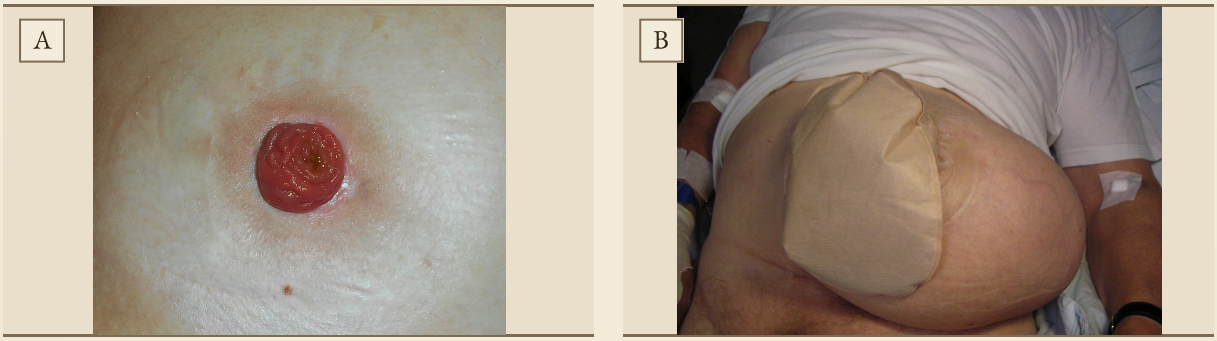


Figura 5. *(A) Ileostomia saudável: mucosa vermelha, úmida, protrusa, com pele ao redor íntegra. (B) Colostomia com grande hérnia paraestomal, a complicação tardia mais comum: o abaulamento ao redor do estoma descola a placa e causa vazamento.*

(A) Salicyna, CC BY-SA 4.0 · (B) Mikael Häggström, CC0 · Wikimedia Commons

Tabela 9. *Complicações das estomias*

Quando	Complicação	O que reconhecer e fazer
Precoces	Isquemia e necrose	Mucosa escura ou preta; se ultrapassar a fáscia, reoperar
	Retração e separação mucocutânea	Estoma afundado ou pele descolada; placa convexa, curativo da ferida
	Dermatite periestomal	A mais frequente; quase sempre vazamento ou recorte largo: corrigir a causa
	Alto débito (ileostomia)	Acima de cerca de 1,5 L/dia: perda de água, sódio e magnésio, desidratação e insuficiência renal; repor e reduzir o débito
Tardias	Hérnia paraestomal	Abaulamento ao redor do estoma; cinta, ajuste do equipamento ou cirurgia
	Prolapso	Alça que se exterioriza demais; mais em colostomia em alça
	Estenose	Orifício estreito, fezes afiladas, dificuldade de esvaziar
	Bloqueio alimentar	Ileostomia sem débito, cólica e distensão após alimento fibroso

Troca da bolsa de colostomia: o passo a passo do OSCE

i. Identifique o paciente, explique o procedimento, peça consentimento e garanta privacidade.

ii. Higienize as mãos, calce luvas e separe bolsa, medidor, tesoura, gaze, água e saco de descarte.

iii. Esvazie a bolsa, se preciso, e solte a placa devagar, rente à pele, enquanto a outra mão apoia a pele.

iv. Inspecione o **estoma** (cor, umidade, altura) e a **pele ao redor**; olhe o verso da placa retirada para ver por onde vazou.

v. Limpe com água morna (ou soro fisiológico) e sabão neutro, sem esfregar. Não use álcool, éter, óleo ou creme sob a placa.

vi. **Seque bem** a pele: placa em pele úmida não adere.

vii. **Meça** o estoma com o medidor (nos dois eixos, se for oval) e recorte a placa **do tamanho do estoma, com folga mínima**: sem apertar a mucosa e sem deixar pele exposta.

viii. Adjuvantes só com indicação: **pó** na pele úmida ou lesada (retire o excesso); **pasta ou anel** para vedar dobras e desníveis. Nenhum deles corrige uma placa mal recortada.

ix. Cole a placa centrada, de baixo para cima, pressionando por alguns segundos; encaixe e feche a bolsa e confira a vedação.

x. Descarte o material, retire as luvas e higienize as mãos. Registre o aspecto do estoma, da pele e do efluente.

xi. **Oriente:** esvaziar quando estiver entre **um terço e metade cheia**; trocar a placa no intervalo do fabricante e na hora se houver vazamento, ardor ou coceira (fita por cima não resolve); procurar ajuda se o estoma escurecer, doer muito ou parar de funcionar com distensão.

Capítulo V

Armadilhas e sequência mental

Tabela 10. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Tratar sem biópsia	Imagem sugere; o diagnóstico de câncer é histológico
Rastrear quem tem sintoma	Sangramento, anemia ou mudança do hábito pedem colonoscopia diagnóstica, não FIT
Pedir CEA para diagnosticar	CEA serve para prognóstico e seguimento
Tratar reto como cólon	Reto médio e baixo precisa de RM de pelve; T3–T4 ou N+ recebe neoadjuvância antes
Ressecar o reto obstruído na urgência	A conduta é derivar e depois estadiar e tratar
"D2 = tirar baço e pâncreas"	D2 retira cadeias linfonodais; esplenectomia não é rotina
Operar linfoma MALT	O tratamento inicial é erradicar o *H. pylori*
Recortar a placa larga "por segurança"	A pele exposta ao efluente é a principal causa de dermatite
Achar que estoma escuro "é normal no começo"	Edema é normal; cor escura exige avaliação urgente (congestão ou isquemia, e até onde vai)

A sequência mental em 30 segundos

i. Qual sintoma levou à suspeita? Disfagia, dispepsia com alarme, anemia, mudança do hábito, sangramento.

ii. Confirme com endoscopia ou colonoscopia **com biópsia**.

iii. Estadie: TC para metástase; ecoendoscopia no esôfago e no estômago; RM de pelve no reto.

iv. Decida pelo estádio: endoscopia no muito inicial, cirurgia, ou tratamento antes da cirurgia no localmente avançado.

v. Na urgência, resolva a complicação (obstrução, perfuração, sangramento) sem perder a chance de cura.

vi. Se houver estomia: demarque antes, cuide da pele e oriente o paciente.

Complemento

Pontos clássicos de prova

Classificações e epônimos que as provas ainda cobram.

Tabela 11. *O que mais cai*

Tema	Ponto de prova	Observação
Borrmann (gástrico avançado)	I polipoide; II ulcerado com bordas nítidas; III ulcerado e infiltrativo; IV infiltrativo difuso (linite plástica)	O tipo III é o mais comum; o IV tem o pior prognóstico
Siewert (junção esofagogástrica)	I: centro 1–5 cm acima da junção; II: de 1 cm acima a 2 cm abaixo; III: 2–5 cm abaixo	I se comporta como esôfago; III como estômago
Krukenberg	Metástase ovariana com células em anel de sinete	A origem mais comum é o estômago
Irmã Maria José	Nódulo umbilical metastático	Implante peritoneal, não linfonodo
Polipose adenomatosa familiar	Gene APC; centenas a milhares de adenomas; câncer quase certo sem cirurgia	Colectomia profilática; Gardner (osteomas, tumores desmoides)
Síndrome de Lynch	Genes de reparo do DNA; câncer colorretal mais jovem e mais à direita; endométrio	Amsterdã (3 parentes, 2 gerações, 1 antes dos 50) sugere Lynch, mas não exclui; hoje se pesquisa MMR/MSI no tumor
Pólipo de maior risco	Adenoma viloso, maior que 1 cm, com displasia de alto grau	Hiperplásico pequeno do reto tem baixo risco
Sinal da "maçã mordida"	Estreitamento anelar e irregular no enema opaco ou no esofagograma	Sugere tumor, mas o diagnóstico é a biópsia
Gastrectomia profilática	Portadores de variante patogênica do CDH1, após aconselhamento genético	O câncer difuso cresce sob a mucosa e escapa da endoscopia
Esôfago de Barrett	Metaplasia intestinal no esôfago distal	O risco relativo é alto, mas o absoluto por ano é baixo

Fontes: JGCA 2025; ASCRS 2022 e 2023; conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- Japanese Gastric Cancer Association. Japanese Gastric Cancer Treatment Guidelines 2025 (7th edition). *Gastric Cancer*. 2026;29(2):271–299.
- Al-Batran SE et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4). *Lancet*. 2019;393:1948–57.
- van Hagen P et al. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal or junctional cancer (CROSS). *N Engl J Med*. 2012;366:2074–84.
- Hoeppner J et al. Perioperative chemotherapy or preoperative chemoradiotherapy in esophageal cancer (ESOPEC). *N Engl J Med*. 2025;392:323–35.
- Vogel JD et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the management of colon cancer. *Dis Colon Rectum*. 2022;65:148–77.
- Langenfeld SJ et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the management of rectal cancer 2023 supplement. *Dis Colon Rectum*. 2023;66:18–31.
- Instituto Nacional de Câncer. SUS adota novo exame para detectar câncer de intestino antes de sintomas. Notícia de 21/05/2026. gov.br/inca.
- Salvadalena G et al. WOCN Society and ASCRS position statement on preoperative stoma site marking for patients undergoing colostomy or ileostomy surgery. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2015;42(3):249–52.
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SAS/MS nº 400, de 16 de novembro de 2009. Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no SUS (garante bolsas, adjuvantes e acompanhamento).

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Radiology 0002 Nevit.jpg*: Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0.
- *Esophageal adenoca.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Linitis plastica.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Virchow'sNodeMark.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Colon cancer; Stricture of colon (título original em télugo).jpeg*: Dr. Gannavarapu Narasimhamurthy, CC0.
- *Dickdarmileus bei hochgradig stenosierendem Deszendenskarzinom 91M - CR Linksseitenlage und ap und CT koronar - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *ColonCaWithMetsMark.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Ileostomy 2017-02-20 5349.jpg*: Salicyna, CC BY-SA 4.0.
- *Colostomy and parastomal hernia.JPG*: Mikael Häggström, CC0.